PRISE EN CHARGE DE L'HEPATITE VIRALE C : BILAN DE 10 ANS D'EXPERIENCE A BOBO-DIOULASSO

Nom du présentateur : Mâli KOURA

Mâli KOURA[1,2], Delphine P ZONGO-NAPON[1,2], Isabelle Laura ECYE[3], Appolinaire SAWADOGO[1,3].

1. **Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS)**
2. **Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA).**
3. **Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS).**

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction (1/3)

- **Problème de santé publique à l'échelle mondiale** :
  - Cinquante millions de personnes infectées par le virus de l'hépatite C
  - Risque élevé de complications chroniques graves: cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.
- **L'Afrique de l'Ouest, une des régions les plus touchées:**
  - Faible accessibilité au diagnostic précoce,
  - Pratiques médicales à risque,
  - Déficit en ressources thérapeutiques

Introduction (2/3)

- **Au Burkina Faso**, l'HVC = un enjeu majeur de santé publique:
  - Prévalence estimée à 3,6% (Meda et coll.).
  - Mortalité liées aux hépatites chroniques : 900 cas/an
- **Cette dernière décennie:**
  - Avènement des AAD,
  - Révolution dans le traitement de l'HVC dans le monde par: efficacité, tolérance et durée de traitement réduit

Introduction (3/3)

❑ Au Burkina Faso, la problématique des hépatites virales:

- ❖ Élaborer un plan stratégique national de lutte contre ces infections
- ❖ Élaboration de protocoles nationaux pour simplifier la PEC
- ❖ Gratuité des AAD depuis septembre 2022
- ❖ Malgré ces efforts, des défis subsiste en matière d'accès équitable au traitement, et au suivi post-thérapeutique

Objectif (1/1)

Dresser le bilan de dix années de prise en charge de l'hépatite virale C à Bobo-Dioulasso, en mettant en lumière les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, ainsi que les perspectives d'amélioration pour une prise en charge plus efficiente dans notre contexte

Matériel et méthode(s) (1/3)

- **Type, période et cadre d'étude**
  - Étude transversale descriptive à collecte rétrospective réalisée de janvier 2015 à décembre 2024 (10 ans)
  - Service d'hépato-gastro-entérologie du CHUSS,
  - Centre de l'association assaut-Hépatites
- **Critères d'inclusion:** patients d'âge ≥ 15 ans, charge virale C détectable (> 15UI/mL) et ayant bénéficié d'une prise en charge médicale pour l'hépatite virale C

Matériel et méthode(s) (2/3)

❑ Échantillonnage

- ❖ **Recensement** exhaustif des cas d'HVC remplissant nos critères d'inclusion
- ❖ **Taille de l'échantillon (**formule de Schwartz):

$n = z^2 \times p (1 - p) / m^2$

n = 53 patients

Matériel et méthode(s) (3/3)

❑ Collecte, traitement et analyse des données

- ❖ Dossiers médicaux de consultation
- ❖ Fiche de collecte
- ❖ Masque de saisie Kobotoolbox
- ❖ Base de données Excel
- ❖ Traitement et analyse logiciel SPSS version 25
- ❖ Statistiques descriptives

Résultats (1/11)

❑DIAGRAMME DE FLUX

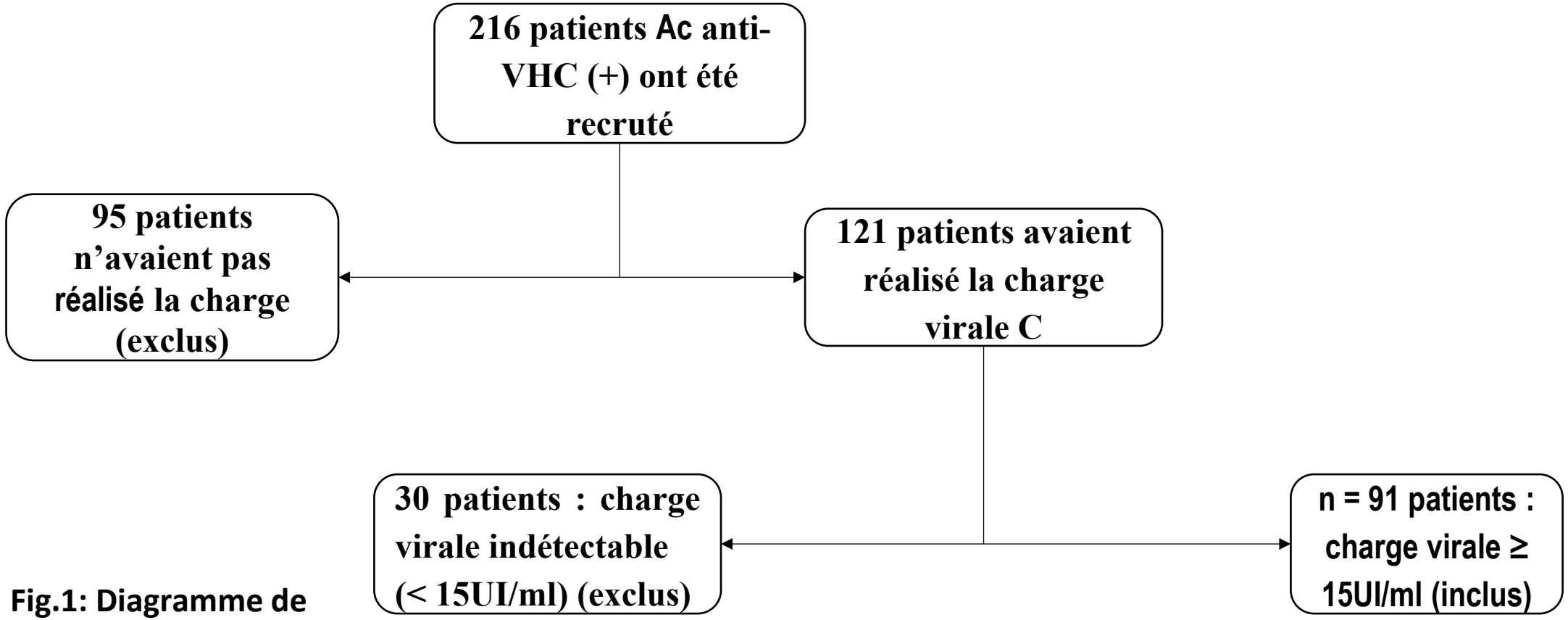

Fig.1: Diagramme de flux des patients reçus

Résultats (2/11)

❑ Caractéristiques sociodémographiques des patients (N = 91)

❖ **Sexe:**

- **M = 52 (57,1%)**
- F = 39 (42,9%) *Sex-ratio* = 1,33

❖ **Âge**

- Moyenne d'âge = 49,02 ± 13,44 ans, extrêmes 21 et 80 ans
- Tranche d'âge prédominante : [51-60] (26,4%)

Résultats (3/11)

❑ Aspects cliniques

❖Circonstances de découverte

Tableau 1: Répartition des patients selon la circonstance de découverte de l'infection virale C

CDD	Effectifs	proportions
Fortuite	**52**	**57,1**
Dépistage volontaire	19	20,9
complication du VHC	7	7,7
Don de sang	6	6,6
hospitalisation	3	3,3
Campagne de dépistage	3	3,3
Consultation prénatale	1	1,1

Résultats (4/11)

❑ Aspects cliniques

❖Antécédents et facteurs de risque du VHC

Tableau 2: Répartition selon les facteurs de risque médicaux et chirurgicaux N=91

Antécédents	Effectif (n)	Proportion %
Antécédents médicaux		
Transfusion sanguine	11	**12,1**
Ictère	8	8,8
Hémodialyse	1	1,1
Antécédents chirurgicaux		
Soins dentaires	**19**	**20,9**
Intervention chirurgicale	**17**	**18,7**

Résultats (5/11)

❑ Aspects cliniques

❖ Symptômes cliniques

- plus de ¾ (76,9%) des patients asymptomatiques
- **chez les patients symptomatiques (23,1%, n = 21)**
  - douleur abdominale: 47,6%
  - asthénie: 42,9%
  - Hépatomégalie : 19%

Résultats (6/11)

❑ Aspects paracliniques

❖Bilan biologique

- **Charge virale C:**
  - Charge virale C moyenne: **2 457 447,08 UI/ml**
  - Prix: **110 000 FCFA → 30000 Fcfa**
- **Transaminases**
  - ALAT > 35 UI/ml: 49,4% , ASAT > 30 UI/ml: 60,8%, Prix
- **TP bas: 15,2%**

Résultats (7/11)

❑ Aspects paracliniques

❖ Bilan morphologique

- ➢ Echographie: 28,9% de signes d'hépatopathie chronique;
- ➢ **Evaluation de la fibrose**
  - **FIB-4** (**n = 63**):
    - **47,6%** fibrose significative, et **11,1%** fibrose sévère
  - **FibroScan®** (**n = 38**):
    - **fibrose significative ou sévère chez** (**34,2%; n = 13**)

Résultats (8/11)

❑ Aspects thérapeutiques

❖Protocoles thérapeutiques utilisés

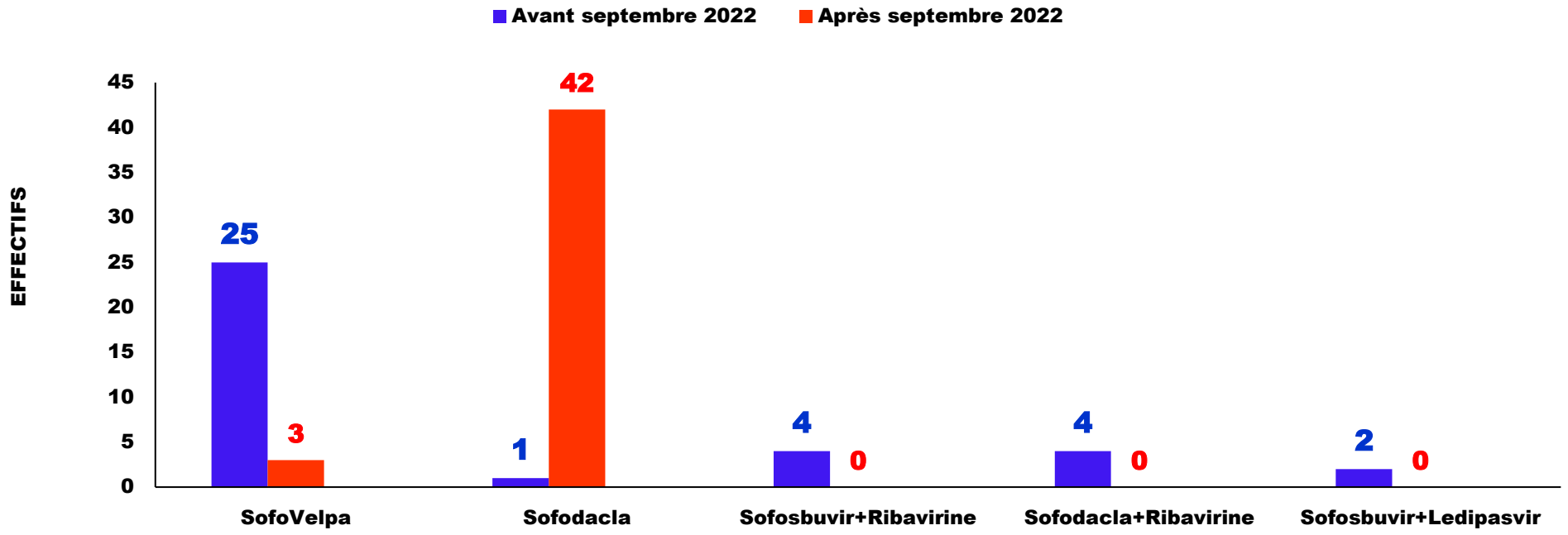

Figure 2 : Répartition des protocoles thérapeutiques utilisés avant et après l'instauration de la gratuité des AAD

Résultats (9/11)

❑ Aspects thérapeutiques

❖ Patients traités par AAD

- ➢ Traitement entamé: **60,4%** (55/91)
- ➢ Traitement terminé: **74,5%** (41/55)

❖ Résultats

- ➢ CV 24 semaines après l'arrêt du traitement: **58,5%** (24/41)
- ➢ RVS = **91,7%** (22/24) patients
- ➢ Effets secondaires: 3 élévations transitoires de la créatininémie

Résultats (10/11)

❑ Difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients

❖ **Coût et disponibilité du traitement**

- Fcfa: **1470000** (2016) à 264000 (2019)
- Gratuité Sofosbuvir/Daclatasvir (2022) et rupture de stock

❖ **Coût élevé de la charge virale : 30000 – 55000 Fcfa**

❖ **Insuffisance en ressource humaine:**

- 2015-2017: PEC au CHUSS uniquement

❖ **Perdus de vue: 67% (61/91)**

Résultats (11/11)

❑Difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients

❖Patients perdus de vue (PDV)

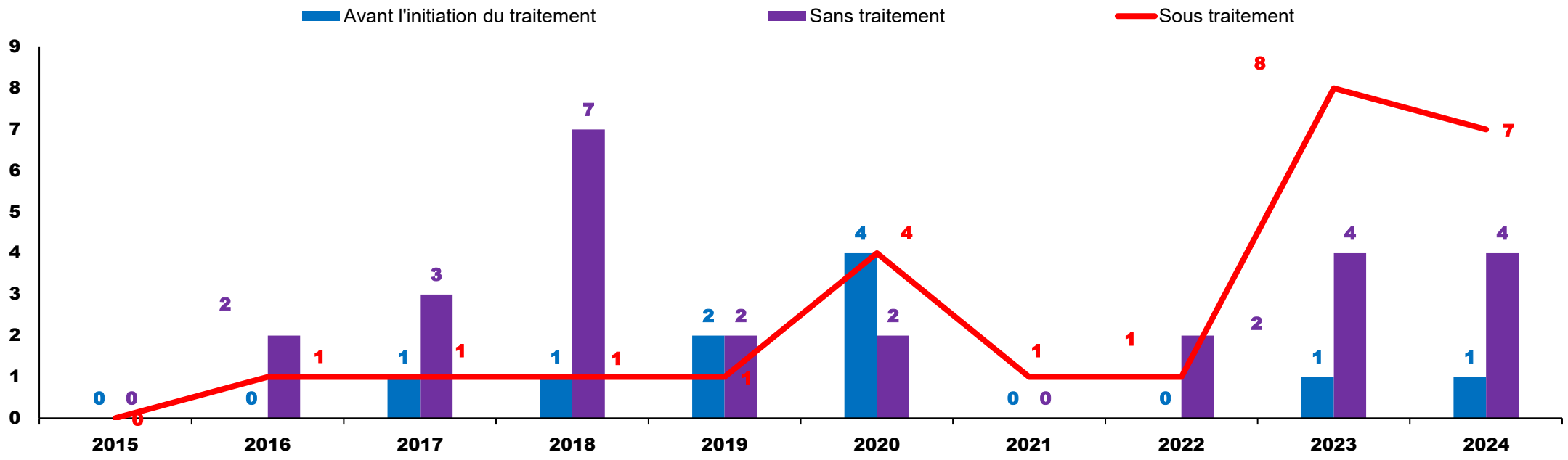

Fig.6: Evolution du nombre de patients suivis pour HVC perdus de vues de 2015 à 2024.

Conclusion (1/1)

- Obstacles : financiers, géographiques, manque d'information
- Perspectives :
  - L'antigène de capside = alternative prometteuse, coût-efficace
  - Explorer les freins au test ARN pour améliorer l'accès aux soins
  - Objectif : optimiser la prise en charge

Merci pour votre attention